

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS (OMS ASSIST V3.0)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Cribado Universal y Estratificación de Riesgo de Policonsumo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias (ASSIST V3.0).
Nombre Original (Inglés)	<i>The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST).</i>
Autores del Diseño Original	Grupo de Investigación Colaborativa de la OMS: Drs. Rachel Humeniuk, Robert Ali, Thomas F. Babor, Maristela G. Monteiro et al. (2002, 2010).
Adaptación al Español	Organización Mundial de la Salud (OMS / OPS) y Ministerio de Sanidad y Consumo / Plan Nacional sobre Drogas.
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Detección temprana en atención primaria, urgencias, salud mental y adicciones.
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica estructurada o autoinforme guiado de 8 preguntas clave sobre 10 sustancias psicoactivas.
Población Diana y Rango	Adolescentes y adultos (a partir de 14-16 años). Población general asistencial y consultantes ambulatorios.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos (más breve si el consumo es exclusivo de una o dos sustancias).
Régimen de Licencia	Dominio público internacional y abierto (OMS). Libre utilización clínica y epidemiológica no comercial.

2. MARCO TEÓRICO Y MODELO DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA OMS

El instrumento ASSIST fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud tras un riguroso estudio de campo multicéntrico en seis países (Australia, Brasil, Irlanda, Tailandia, Reino Unido y Zimbabue) para responder a una necesidad médica prioritaria: disponer de una herramienta estandarizada, rápida y comprehensiva capaz de evaluar el **espectro completo del consumo de sustancias** en entornos de atención sanitaria primaria.

A diferencia de las pruebas monográficas (como el AUDIT para alcohol o el Fagerström para nicotina), el ASSIST evalúa simultáneamente **10 clases de sustancias**, permitiendo desvelar patrones de **policonsumo encubierto** (por ejemplo, combinación simultánea de alcohol, cannabis, cocaína y benzodicepinas). Su fundamento teórico se basa en el **continuum de riesgo y daño**: identifica no solo la dependencia instaurada, sino el consumo experimental o de riesgo moderado antes de que genere secuelas irreversibles.

3. LAS 10 CLASES DE SUSTANCIAS EVALUADAS (SOLO USOS NO MÉDICOS)

a. Tabaco	Cigarrillos comerciales, puros, tabaco de liar, pipa, picadura o rapé.
b. Bebidas alcohólicas	Cerveza, vino, sidra, licores destilados, aperitivos y combinados.
c. Cannabis	Marihuana, hachís, aceite de THC, preparados concentrados.
d. Cocaína	Clorhidrato de cocaína en polvo, crack, base libre y pasta base.
e. Estimulantes anfetamínicos	Anfetaminas (<i>speed</i>), metanfetamina (<i>crystal</i>), éxtasis, MDMA y derivados sintéticos.
f. Inhalables	Disolventes volátiles, colas, pegamentos, poppers, gasolina, gas butano y óxido nitroso.
g. Sedantes / Hipnóticos	Benzodicepinas (diazepam, lorazepam, alprazolam) o zolpidem consumidos sin receta o en exceso.
h. Alucinógenos	LSD, hongos psilocibios, ketamina, PCP, mescalina, ayahuasca y drogas disociativas.
i. Opioides	Heroína, morfina, tramadol, fentanilo, codeína o metadona sin prescripción médica.
j. Otras sustancias	Cualquier otra sustancia psicoactiva no clasificada (anabolizantes, drogas emergentes).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD PSICOMÉTRICA

Consistencia Interna	Excelente confiabilidad en todas las clases de sustancias: coeficientes alfa de Cronbach de 0.80 a 0.93 en los ensayos multicéntricos de validación de la OMS (Humeniuk et al., 2008, 2010).
Validez Concurrente	Correlaciones elevadas y estadísticamente significativas con pruebas de referencia estándar: AUDIT (r = 0.82), Test de Fagerström (r = 0.78), Addiction Severity Index - ASI (r = 0.76) y MINI-Plus (r = 0.84).
Sensibilidad y Especificidad	Sensibilidad diagnóstica entre el 84% y el 95% y especificidad entre el 82% y el 94% para discriminar entre consumo de riesgo y trastorno por dependencia según criterios CIE-10 y DSM-IV/5.
Rendimiento Transcultural	Estructura invariante confirmada en países de habla hispana, demostrando alta aceptabilidad tanto en pacientes como en profesionales sanitarios.

5. CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA POR SUSTANCIA (PES)

Para cada una de las sustancias consumidas se calcula una puntuación independiente denominada **Puntuación Específica por Sustancia (PES)** sumando las respuestas a las preguntas 2 a 7:

$$PES = P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7$$

- Rango PES para Alcohol y demás drogas: **0 a 39 puntos**.
- Rango PES para Tabaco: **0 a 31 puntos** (la Pregunta 5 sobre incumplimiento de roles no se aplica a tabaco).
- **Pregunta 8 (Vía Inyectada)**: No suma a la PES pero actúa como alerta médica crítica cualitativa e independiente.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA OMS

Nivel de Riesgo	PES Alcohol	Demás Sustancias	Significación Clínica y Conducta Asistencial Recomendada
Bajo Riesgo	0 a 10 puntos	0 a 3 puntos	Patrón de consumo de bajo riesgo o abstinencia. Acción: Educación para la salud, refuerzo positivo y prevención primaria.
Riesgo Moderado	11 a 26 puntos	4 a 26 puntos	Consumo de riesgo o daño perjudicial incipiente. Acción: Intervención Breve ASSIST de 10 pasos con entrega de folleto de autoayuda.
Alto Riesgo	>= 27 puntos	>= 27 puntos	Alta probabilidad de dependencia y daño orgánico/psicosocial grave. Acción: Derivación especializada a Centro de Adicciones (CAD/CAS/UCA).

SIGNIFICACIÓN DEL CONSUMO POR VÍA INYECTADA (PREGUNTA 8):

Una respuesta afirmativa en los últimos 3 meses sitúa automáticamente al paciente en situación de **alto riesgo infectocontagioso y de sobredosis**, independientemente de la puntuación PES obtenida, exigiendo activación inmediata de protocolos de reducción de daños.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN BREVE DE LA OMS

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN BREVE ASOCIADA AL ASSIST:

1. **Permiso:** Preguntar al paciente si está dispuesto a revisar los resultados del cuestionario.
2. **Devolución (Feedback):** Mostrar la Tarjeta de Respuestas y señalar la puntuación PES obtenida en cada sustancia.
3. **Riesgos específicos:** Explicar los daños asociados al consumo de cada sustancia que puntuó en riesgo moderado o alto.
4. **Percepción:** Explorar qué piensa o cómo se siente el paciente respecto a esos resultados.
5. **Consejo claro:** Ofrecer recomendación médica no moralizante de reducir o abandonar el consumo.
6. **Preocupación:** Sondar el grado de preocupación del paciente y su nivel de motivación para el cambio.
7. **Fortalezas:** Identificar recursos personales y de soporte afectivo para favorecer el cese o la reducción.
8. **Autoayuda:** Entregar la guía práctica de autoayuda de la OMS para personas que desean reducir su consumo.
9. **Plan de acción:** Acordar conjuntamente metas realistas a corto plazo (fechas, reducción gradual, sustitución de rutinas).
10. **Seguimiento:** Agendar una consulta de revisión y refuerzo a las 4-6 semanas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DETECCIÓN DE POLICONSUMO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paciente: Varón de 27 años, empleado de comercio, remitido por su médico de familia tras acudir a consulta solicitando ansiolíticos por insomnio y crisis de ansiedad matutina. **Resultados en ASSIST V3.0:** • **Cannabis:** PES = 21 (**Riesgo Moderado**). Consumo diario de hachís/marihuana con craving frecuente y fallos en responsabilidades laborales. • **Alcohol:** PES = 16 (**Riesgo Moderado**). Consumo concentrado de fin de semana con episodios de embriaguez. • **Cocaína:** PES = 8 (**Riesgo Moderado**). Uso recreativo mensual en fiestas con amigos. • **Tabaco:** PES = 14 (**Riesgo Moderado**). 15 cigarrillos al día. • **Vía Inyectada (P8):** No, nunca. **Plan Asistencial:** Se diagnostica policonsumo recreativo en riesgo moderado que precipita sus quejas ansiosas. Se desaconseja iniciar tratamiento con benzodiacepinas por riesgo de adicción cruzada y se aplica la Intervención Breve ASSIST de 10 pasos en dos sesiones sucesivas: se pacta la suspensión completa de la cocaína, un límite semanal de alcohol y la reducción progresiva del cannabis antes de dormir. A los 2 meses, el paciente suspendió la cocaína, redujo a la mitad el cannabis, mejoró notablemente la arquitectura del sueño y remitió la ansiedad diurna.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y REDUCCIÓN DE DAÑOS

ALERTA CRÍTICA: CONSUMO DE OPIOIDES

Cualquier puntuación ≥ 4 en opioides exige advertir sobre riesgo de depresión respiratoria letal por sobredosis, especialmente si se asocia a benzodiacepinas o alcohol. Prescribir naloxona para uso comunitario.

RIESGO DE PATOLOGÍA DUAL

En consultantes con consumo de cannabis o estimulantes y síntomas afectivos o psicóticos comórbidos, evaluar estabilidad clínica y coordinar la intervención con la red de salud mental especializada.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Humeniuk, R., Ali, R., Babor, T. F., Farrell, M., Formigoni, M. L., Jittiwutikarn, J., ... & Simon, S. (2008). Validation of the Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). *Addiction*, 103(6), 1039–1047.
2. Humeniuk, R., Henry-Edwards, S., Ali, R., Poznyak, V., & Monteiro, M. G. (2010). *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Manual for use in primary care*. World Health Organization.
3. WHO ASSIST Working Group (2002). The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Development, reliability and feasibility. *Addiction*, 97(9), 1183–1194.
4. Ali, R., Meena, S., Eastwood, B., Vela, M., & Leggio, L. (2013). Ultra-rapid screening for substance use disorders: The ASSIST-Lite. *Drug and Alcohol Dependence*, 132(1-2), 352–361.